Chronická choroba obličiek podľa KDIGO 2024: čo môže pacient urobiť pre svoje obličky?

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 14.05.2026



Čo môže pacient urobiť pre svoje obličky podľa KDIGO 2024 — diagnostika, životný štýl, krvný tlak, liečba a spolupráca s lekárom. Individuálny plán vždy nastavuje lekár.

Chronická choroba obličiek, často označovaná skratkou CKD z anglického *chronic kidney disease*, neznamená iba „horšie obličkové výsledky“. Je to stav, ktorý ovplyvňuje celé telo: srdce, cievy, krvný tlak, metabolizmus, výživu, kosti, krvotvorbu aj každodennú kvalitu života. Dobrá správa je, že moderná nefrológia dnes pri mnohých pacientoch dokáže spomaliť zhoršovanie funkcie obličiek a znížiť riziko zlyhania obličiek, infarktu, mozgovej príhody či srdcového zlyhávania.

Nové odporúčania KDIGO 2024 zdôrazňujú, že najlepšia starostlivosť o človeka s chronickou chorobou obličiek nie je založená na jedinom lieku ani na jedinom laboratórnom výsledku. Ide o kombináciu správnej diagnostiky, pravidelného sledovania, úpravy životného štýlu, kontroly krvného tlaku, vhodnej liečby a aktívnej spolupráce pacienta so zdravotníckym tímom [ref:1,2].

Poznať svoje štádium ochorenia je základ

Pri chronickej chorobe obličiek je dôležité vedieť nielen to, že „obličky sú oslabené“, ale aj prečo sú oslabené a aké je riziko ďalšieho zhoršovania. Lekár hodnotí najmä odhadovanú glomerulovú filtráciu (eGFR) a množstvo bielkoviny, najmä albumínu, v moči. Práve kombinácia eGFR a albuminúrie pomáha určiť štádium a rizikovosť ochorenia.

Pacient by sa mal pýtať na svoje výsledky a rozumieť im v praktickom kontexte. Nie preto, aby nahradil lekára, ale aby sa stal aktívnym partnerom v starostlivosti. Užitočné otázky sú napríklad:

- Aké mám eGFR?
- Mám albumín alebo bielkovinu v moči?
- Ako sa moja funkcia obličiek mení v čase?
- Aký je môj cieľový krvný tlak?
- Ktoré lieky chránia moje obličky a srdce?

- Čo mám robiť pri horúčke, vracaní, hnačke alebo dehydratácii?

Životný štýl nie je doplnok liečby, ale jej súčasť

KDIGO 2024 zdôrazňuje komplexný prístup: zdravšia strava, primeraný pohyb, nefajčenie, kontrola hmotnosti, liečba vysokého krvného tlaku a úprava lipidov dokážu spolu s vhodnými liekmi spomaliť progresiu CKD a znížiť kardiovaskulárne riziko.

Strava pri chronickej chorobe obličiek nemá byť trestom. Má byť premyslená, pestrá, bezpečná a prispôsobená štádiu ochorenia. Vo všeobecnosti sa odporúča vyšší príjem zeleniny, ovocia, celozrnných potravín, vlákniny, strukovín, rastlinných bielkovín, nenasýtených tukov a orechov. Naopak, vhodné je obmedziť spracované mäso a ultraspracované potraviny, ktoré často obsahujú veľa soli, cukru, nevhodných tukov a prídavných látok.

Odporúčania KDIGO uvádzajú príjem soli pod 5 gramov denne, čo zodpovedá približne 2 gramom sodíka denne. Pri bielkovinách sa u mnohých dospelých pacientov s CKD odporúča príjem približne do 0,8 g/kg telesnej hmotnosti za deň, ak lekár alebo nutričný terapeut neurčí inak. Dôležité je, že tieto odporúčania sa majú individualizovať. Iné potreby má pacient v skoršom štádiu CKD, iné má pacient s pokročilým ochorením, iné diabetik, senior, človek s podvýživou alebo pacient v dialyzačnom programe.

Draslík: nie vždy je problémom ovocie

Mnohí pacienti s ochorením obličiek sa obávajú draslíka. Táto opatrnosť je pochopiteľná, pretože vysoká hladina draslíka v krvi môže byť nebezpečná pre srdcový rytmus. Napriek tomu nie je správne automaticky zakázať všetko ovocie a zeleninu každému pacientovi s CKD.

KDIGO upozorňuje, že zdroj draslíka je dôležitý. Rastlinné potraviny môžu mať nižšiu vstrebateľnosť draslíka a zároveň priaznivý metabolický účinok. Naopak, vysoko spracované potraviny môžu obsahovať draselné prídavné látky s vysokou vstrebateľnosťou. Preto má diéta vychádzať z laboratórnych výsledkov, štádia ochorenia, liekov a celkového klinického stavu, nie iba zo všeobecného zoznamu „zakázaných potravín“.

Krvný tlak je srdcom nefrologickej starostlivosti

Kontrola krvného tlaku patrí medzi najdôležitejšie kroky v liečbe CKD. Zvýšený tlak poškodzuje obličkové cievy a urýchľuje stratu funkcie obličiek. Zároveň zvyšuje riziko infarktu, mozgovej príhody a srdcového zlyhávania.

Cieľový krvný tlak má byť prispôsobený konkrétnemu pacientovi. U niektorých pacientov môže byť cieľ prísnejší, u iných opatrnejší, najmä ak sú krehkí, majú závraty pri vstávaní, vysoké riziko pádov alebo nízky tlak. Pri pokročilejšej CKD sa môže tlak zvyšovať aj pre zadržiavanie soli a vody, čo sa často prejaví opuchmi členkov alebo zhoršeným dýchaním. Vtedy môžu byť potrebné diuretiká, teda lieky podporujúce vylučovanie nadbytočnej tekutiny.

Lieky, ktoré chránia obličky a srdce

Moderná liečba CKD sa výrazne posunula. KDIGO 2024 zdôrazňuje lieky, ktoré dokážu spomaliť progresiu obličkového ochorenia a zároveň znížiť kardiovaskulárne riziko.

Medzi základné skupiny patria:

- **inhibítory renín-angiotenzínového systému**, teda ACE inhibítory alebo sartany, najmä pri hypertenzii a albuminúrii,
- **SGLT2 inhibítory**, ktoré znižujú riziko zlyhania obličiek a kardiovaskulárnych komplikácií, a to u vybraných pacientov s diabetom aj bez diabetu,
- **statíny**, najmä u pacientov so zvýšeným aterosklerotickým kardiovaskulárnym rizikom,
- ďalšie lieky podľa individuálnej situácie, napríklad diuretiká, blokátory kalciových kanálov, lieky na diabetes, liečba anémie, metabolickej acidózy, porúch minerálového a kostného metabolizmu alebo porúch draslíka.

Dôležité je neužívať lieky mechanicky. Pacient by mal vedieť, prečo liek užíva, aký má očakávaný prínos a kedy je potrebné kontaktovať lekára.

Čo robiť pri akútnom ochorení a dehydratácii?

Osobitne dôležitá je situácia, keď pacient s CKD dostane horúčku, vracia, má hnačku, málo pije alebo je

dehydratovaný. Vtedy môže prechodne stúpnuť riziko akútneho poškodenia obličiek. Niektoré lieky môžu byť v takýchto dňoch dočasne nevhodné, ale rozhodnutie má byť vopred vysvetlené lekárom.

Pacient by mal mať jasný plán: ktoré lieky užíva stále, pri ktorých má pri dehydratácii zavolať lekárovi a ktoré lieky sa môžu v konkrétnej situácii dočasne prerušiť. Takýto plán je vždy individuálny.

Príznaky CKD netreba zľahčovať

S postupujúcim ochorením obličiek sa môžu objaviť únava, nechutenstvo, opuchy, dýchavica, svalové kŕče, poruchy spánku, svrbenie kože, bolesti kostí a kĺbov, znížená výkonnosť alebo sexuálne ťažkosti. Únava môže súvisieť napríklad s anémiou, zápalom, poruchou spánku alebo celkovou metabolickou záťažou. Nechutenstvo môže sprevádzať metabolickú acidózu alebo pokročilejšiu urémiu.

Tieto príznaky nemajú byť prijaté ako „normálne“. Majú byť pomenované, sledované a liečené, ak je to možné. Niekedy pomôže úprava liečby, inokedy liečba anémie, korekcia acidózy, zmena diéty, kontrola tekutín, liečba svrbenia alebo riešenie porúch spánku.

Psychická a sociálna stránka ochorenia

Chronická choroba obličiek je dlhodobá diagnóza. Prináša neistotu, obavy, zmeny v rodine, práci aj každodennom režime. Pacient môže mať problém prijímať medicínske odporúčania, ak zároveň rieši úzkosť, depresívne prežívanie, finančné starosti alebo sociálnu izoláciu.

Aj preto KDIGO zdôrazňuje holistický prístup. Starostlivosť o človeka s CKD nemá byť iba o kreatiníne, eGFR a tlaku. Má zahŕňať fyzické, psychické, sociálne aj praktické potreby pacienta. Pomôcť môžu pacientské organizácie, dôveryhodné edukačné zdroje, sociálne poradenstvo, psychologická podpora a včasná edukácia o možnostiach liečby vrátane dialýzy a transplantácie, ak sa ochorenie dostane do pokročilého štádia.

Aktívny pacient má lepšiu šancu chrániť svoje obličky

Pacient s CKD by nemal byť pasívnym príjemcom pokynov. Mal by mať prístup k svojim výsledkom, rozumieť svojej liečbe, pýtať sa na riziká a vedieť, čo môže sám ovplyvniť. Praktickým krokom je pripraviť si pred kontrolou krátky zoznam otázok. Rovnako užitočné je priniesť aktuálny zoznam liekov vrátane voľnopredajných prípravkov, výživových doplnkov a liekov proti bolesti.

Osobitnú opatrnosť si vyžadujú nesteroidné protizápalové lieky proti bolesti, napríklad ibuprofén alebo diklofenak, najmä pri dehydratácii, vo vyššom veku, pri užívaní diuretík alebo liekov ovplyvňujúcich renín-angiotenzínový systém. O vhodnej analgetickej liečbe je lepšie poradiť sa s lekárom.

Záver

Chronická choroba obličiek je vážna, ale nie beznádejná diagnóza. Najlepšie výsledky prináša kombinácia včasnej diagnostiky, pravidelného sledovania, zdravej a individualizovanej výživy, kontroly krvného tlaku, nefroprotektívnej liečby, zvládania príznakov a aktívnej spolupráce pacienta so zdravotníckym tímom.

Odporúčania KDIGO 2024 prinášajú jasný odkaz: liečba CKD má byť komplexná, individualizovaná a zameraná nielen na laboratórne hodnoty, ale na človeka ako celok.

Zdroje

1. KDIGO. *KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease*. Kidney International, 2024;105(4S):S117-S314 [ref:1,2].
2. KDIGO. *Top 10 Takeaways for People Living with CKD from the KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease*. Edukačný materiál pre ľudí žijúcich s CKD, 2024. Zdrojový dokument poskytnutý používateľom: Key-Takeaways_KDIGO-2024-CKD-Guideline_People-Living-with-CKD.pdf.
3. KDIGO. *CKD Evaluation and Management*. Oficiálna stránka odporúčania KDIGO 2024 pre hodnotenie a manažment chronickej choroby obličiek [ref:3].

Poznámka pre čitateľov: Tento článok má edukačný charakter a nenahrádza osobné vyšetrenie ani odporúčania vášho nefrológa alebo ošetrujúceho lekára. Liečba chronickej choroby obličiek musí byť vždy

prispôsobená konkrétnemu pacientovi, jeho laboratórnym výsledkom, pridruženým ochoreniam a užívaným liekom.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=chronicka-choroba-obliciek-podla-kdigo-2024-co-moze-pacient-urobit-pre-svoje-oblicky · Nefro-projekt Slovensko.
Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.